

Kolagenózy: praktický klinický pohľad nefrológa na diagnostiku, orgánové riziko a rozhodovanie o liečbe

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščin · Publikované: 20.06.2026

Pri kolagenózach sa v praxi často naráža na dve veci: diagnóza nie je „jednovstupová“ a priebeh vie byť orgánovo rizikový skôr, než sa klinický obraz jasne „zafarbí“ do jednej konkrétnej nozologickej jednotky. Už to, ako si reumatológ systematicky mapuje symptómy, laboratóriá, zobrazenie a funkciu orgánov, je podstatou diagnostického úspechu.

Streamed Up v kontexte RheumaLive pre Kollagenosen 2026 vystihuje, že ide o oblasť s výraznými **diagnostickými aj terapeutickými výzvami** naprieč rôznymi formami ochorení. Nižšie to zhrniem „operačne“, teda tak, aby sa to dalo použiť pri každodennom uvažovaní na ambulancii aj na internom oddelení.

1) Diagnostika nie je pomenovanie. Diagnostika je posúdenie rizika pre orgány

Kľúčový rozdiel medzi bežným nešpecifickým príznakom a kolagenózou je, že kolagenóza sa môže prejavovať rôzne a často sa mení v čase. Preto sa postup opiera o:

- anamnézu a fyzikálne vyšetrenie zamerané na typické symptómy,
- laboratóriá doplnené o vyšetrenie funkcie postihnutých orgánov,
- zobrazovanie (napríklad ultrazvuk, RTG),
- a podľa potreby aj mikroskopické vyšetrenie tkaniva z biopsie, ak to zmení diagnostiku alebo terapiu.

V tejto logike „správna diagnóza“ nie je cieľ, ale prostriedok. Cieľom je včas zachytiť, či už nejde o orgánové poškodenie a aký je potrebný stupeň urgentnosti.

2) Najdôležitejšie „orgánové okná“ v každodennej práci

A) Obličky: ako spoznať prebiehajúcu nefritídu

Pri systémovom lupus erythematosus treba v praxi počítať s možnosťou obličkového postihnutia. Rheuma-Liga uvádza, že zápal v tomto kontexte možno zachytiť vyšetrením moču a medzi prvé viditeľné varovania patria napríklad opuchy členkov pre zadržiavanie tekutín. Ak sa moč „pení“, môže to byť signál vysokého obsahu bielkovín a pacient by mal byť vyšetrený lekárom.

Praktické posolstvo: pri kolagenóze nepodceňuj moč ani zmeny hydratácie a edémy, lebo práve nefritída môže byť rozhodujúca pre prognózu.

B) Svaly: keď dominuje slabosť, myšli na myozitídové spektrum

Ak dominuje svalová slabosť, Rheuma-Liga spomína, že príčinou môže byť polymyozitída alebo dermatomyozitída. Typicky sa v laboratóriách hľadajú zvýšené svalové enzýmy. K diagnostike pomáha ultrazvuk svalov, včasné informácie môže priniesť aj MRI a v prípade potreby sa používa aj elektromyografia. Definitívny dôkaz zápalových procesov vo svalu môže poskytnúť biopsia.

Praktické posolstvo: pri svalovej slabosti sa neopieraj iba o subjektívny dojem a jeden odber. Kombinuj kliniku, enzýmy a zobrazovanie a zisti, či ide o zápalové postihnutie s potenciálom odpovedať na imunosupresiu.

3) Autoprotilátky: silný smerovník, nie náhrada kliniky

Autoprotilátky môžu diagnózu výrazne urýchliť. Rheuma-Liga uvádza, že antinukleárne protilátky (ANA) sú pri kolagenózach typicky prítomné a bližšie určenie typu protilátok pomáha rozlíšiť jednotlivé kolagenózy.

Konkrétne príklady (ako rámec myslenia):

- pri aktívnom systémovom lupus erythematosus sa môžu v krvi zisťovať protilátky proti dsDNA (anti-dsDNA),
- pri Sjögrenovom syndróme sa nájdu iné podskupiny ANA, napríklad anti-Ro a anti-La.

Praktické posolstvo: ak protilátky „nesedia“ k fenotypu, neber výsledok ako hotovú diagnózu ani ako hotové vylúčenie. Je to signál, ktorý treba prepojiť s orgánovou klinikou a dynamikou.

4) Terapeutická logika: liečiť podľa rizika orgánov, nie podľa subjektívneho dojmu

Streamed Up zdôrazňuje, že pri Kollagenosen 2026 existujú diagnostické aj terapeutické výzvy. To v klinickom jazyku znamená, že liečba sa nedá nastaviť správne bez toho, aby si mal pod kontrolou:

- čo je aktívne (zápalová aktivita),
- kde je aktívne (ktorý orgán je ohrozený),
- a aké je riziko rýchlej progresie.

Inými slovami: rozdiel medzi „pacient má príznaky“ a „pacient má aktívne orgánové ohrozenie“ mení rýchlosť a intenzitu rozhodovania.

5) Praktický algoritmus uvažovania v piatich krokoch (nejde o jediný možný postup)

1. **Zmapuj fenotyp:** symptómy a fyzikálne nálezy.
2. **Zhodnoť orgány:** moč, funkcie, svalová slabosť, dýchacie prejavy, neurologické znaky – podľa domény.
3. **Doplň laboratóriá a zobrazovanie:** cielene (nie všeobecne „čo vyjde“).
4. **Interpretuj protilátky v kontexte:** ANA a špecifické protilátky sú smerovník, nie rozsudok.
5. **Ak otáznik mení manažment, zintenzívni diagnostiku:** vrátane zvažovania mikroskopického vyšetrenia, ak je to naozaj rozhodujúce.

6) Záver

Kolagenózy sú diagnosticky náročné práve preto, že sa prejavujú rôznorodo a často sa mení pomer medzi systémovými symptómami a orgánovým rizikom. Prakticky najviac pomáha orgánový prístup: kombinácia kliniky s funkciami orgánov, ciele laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia a interpretácia autoprotilátok v kontexte pacienta. Keďže v tejto oblasti sú reálne diagnostické aj terapeutické výzvy, manažment treba viesť tak, aby chránil orgány včas.

Zdroj (podujatie): *streamed-up.com*, „Kollagenosen 2026“ (RheumaLive, 2026). [Link na zdroj](#).

Zdroj (diagnostika kolagenóz): Rheuma-Liga, „Kollagenosen“. [Link na zdroj](#).

Zdroj: <https://nefro.polascin.net/article.php?slug=kolagenozy-klinicky-pohlad-nefrologa-diagnostika-organy> · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.